

Manual integral de limpieza y desinfección

Manual | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

1. Objetivo y resultado esperado

Establecer métodos seguros de limpieza y desinfección de consultorio, equipos y elementos terapéuticos para reducir contaminación entre usuarios.

2. Alcance y condiciones de uso

Áreas, superficies, camillas, accesorios y material reutilizable no crítico, con módulos separados para contacto con mucosa y dispositivos críticos. El proceso depende del producto, material e instrucciones reales.

3. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidad
Fisioterapeuta responsable	Valorar, individualizar, informar, vigilar y registrar.
Ejecutor según proceso	Aplicar la técnica o tarea para la que tiene competencia.
Verificador o titular	Comprobar recursos, evidencias y acciones de mejora.

4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

1. Inventariar áreas y superficies, tipo de contacto, material y suciedad

Inventariar áreas y superficies, tipo de contacto, material y suciedad. Clasificar elemento no crítico, semicrítico o crítico; no aplicar automáticamente desinfección de bajo nivel a sondas de mucosa ni a instrumentos que ingresan tejidos estériles.

2. Elegir detergente y desinfectante con autorización pertinente al uso, ficha técnica, ficha

Elegir detergente y desinfectante con autorización pertinente al uso, ficha técnica, ficha de seguridad y compatibilidad. Registrar dilución, concentración de uso, contacto, enjuague, protección y conservación de la etiqueta, sin inventar una receta universal.

3. Preparar área sin pacientes, retirar residuos y ropa usada, proteger material limpio y señ

Preparar área sin pacientes, retirar residuos y ropa usada, proteger material limpio y señalizar piso húmedo. Realizar manos y colocar protección según exposición y ficha; separar utensilios de sanitario y atención.

4. Limpiar antes de desinfectar: retirar suciedad, aplicar detergente compatible y fricción d

Limpiar antes de desinfectar: retirar suciedad, aplicar detergente compatible y fricción de limpio a sucio y de arriba abajo. Cambiar paño o solución sucios, evitando devolver paños contaminados a un recipiente limpio.

5. Aplicar desinfectante por método compatible, mantener humedad durante el contacto indicado

Aplicar desinfectante por método compatible, mantener humedad durante el contacto indicado, enjuagar si el fabricante lo exige y dejar seguro para uso. No mezclar químicos, no nebulizar para reemplazar fricción y no rociar conectores eléctricos.

6. Entre pacientes retirar barrera y procesar camilla, apoyos y elementos compartidos

Entre pacientes retirar barrera y procesar camilla, apoyos y elementos compartidos. Electrodo, cabezales, bandas y ayudas siguen fabricante; desconectar equipos cuando corresponde y evitar inmersión no autorizada.

7. Al cierre limpiar pisos y sanitario con elementos diferenciados, superficies altas según p

Al cierre limpiar pisos y sanitario con elementos diferenciados, superficies altas según programación y puntos de contacto. La frecuencia profunda se define por uso y riesgo; no reemplaza la limpieza entre pacientes.

8. Verificar ausencia de suciedad, secado, integridad, producto y registro

Verificar ausencia de suciedad, secado, integridad, producto y registro. Ante omisión repetir antes de liberar y documentar causa. Una observación visual no acredita esterilidad ni mide por sí sola la eficacia microbiológica.

Control, frecuencia y corrección

5. Verificación de la ejecución

Entre pacientes: superficies de contacto y elementos compartidos según uso e instrucciones.

Apertura y cierre diario: condición de área y tareas asignadas; limpieza profunda semanal propuesta que debe ajustarse a riesgo.

Derrame: atención inmediata con procedimiento específico, no esperar al cierre.

Producto concentrado, fecha y contacto siempre trazables; no registrar tareas no realizadas.

Adherencia local: tareas conformes observadas / tareas observadas x 100.

Momento	Comprobación y conducta
Antes	Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.
Durante	Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso.
Después	Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.
Ante hallazgo	Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.

6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

7. Aplicación normativa específica

11.1.5 y 11.3.1.22-26: información documentada, prácticas seguras, recursos y formación. Limitar técnicas al portafolio y verificar condiciones reales.

8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

Matriz operativa por contacto y superficie

La selección de producto se completa con etiquetas e instrucciones reales. Esta matriz describe qué controlar; los valores no se rellenan con porcentajes o tiempos supuestos.

Elemento / contacto	Secuencia local	Verificación
Camilla y apoyos, piel íntegra	Retirar textiles y barrera usados. Fricción con detergente compatible, retiro de suciedad, desinfección, contacto y secado según producto.	Superficie íntegra, sin residuos; humedad y contacto completos antes de siguiente paciente.
Cabezal y accesorios, piel íntegra	Retirar gel. Limpiar y desinfectar según modelo, protegiendo conexiones y sin inmersión no autorizada.	Capa de gel retirada, material compatible e integridad y funcionamiento.
Electrodos y esponjas	Identificar uso único, individual o reutilizable; seguir fabricante y retirar deteriorados.	No compartir autoadhesivos individualizados ni sumergir cables o conectores.
Bandas, balones, pesas y ayudas	Limpiar contactos según uso y compatibilidad; secar y guardar; revisar desgaste.	Elemento procesable, sin grietas y mecánicamente seguro.
Sonda o elemento de mucosa	Clasificar como semicrítico y aplicar circuito autorizado de mayor nivel; funda no sustituye automáticamente proceso.	Proceso validado, instrucciones y trazabilidad. Si no existe, no ofertar contacto interno.
Instrumental crítico autorizado	Limpieza previa y esterilización por proceso validado, controles y almacenamiento.	Liberación documentada. Agujas de un solo uso quedan excluidas del reuso.

Puntos que obligan a retirar

Tapicería agrietada, elemento poroso no procesable, gel o producto de origen incierto, electrodo dañado, manual ausente o empaque contaminado requieren retiro o cuarentena y una alternativa segura. Una limpieza rápida por agenda llena no cumple el proceso definido.

Frecuencias, agenda y capacidad de ejecución

Planificación antes de abrir

Asignar tiempo real entre usuarios para retiro de material, fricción, contacto y secado. La programación debe respetar el tiempo de producto; no sumar pacientes cuando obliga a acortarlo. Verificar insumos, agua, protección y paños diferenciados. Si falta recurso crítico, reprogramar o limitar actividad.

Momento	Tareas	Evidencia
Apertura	Revisar área, limpieza previa, superficies, insumos y circuito limpio.	Condición observada y corrección.
Entre pacientes	Procesar camilla, contacto y material compartido según procedimiento; retirar textiles y residuos generados.	Hora, elemento, producto y contacto, ejecutor y resultado.
Suciedad o derrame	Aislar y ejecutar procedimiento de derrame de inmediato.	Evento, protección, limpieza, desinfección y liberación.
Cierre	Completar superficies, piso y sanitario con circuitos separados; limpiar utensilios y almacenarlos secos.	Planilla de cierre con tareas efectivamente hechas.
Profunda local	Programar rincones, depósitos y superficies menos accesibles; propuesta semanal ajustable a riesgo.	Actividad, área, fecha y verificación; no sustituye entre pacientes.

Contingencias

Ante producto vencido o incompatibilidad no sustituir por otra sustancia sin revisar ficha. Ante falta de tiempo no marcar realizado: detener la rotación del elemento o área. Ante error de mezcla, exposición o salpicadura aplicar ficha y ruta clínica u ocupacional y analizar causa.

Verificación de calidad y adopción de productos

Observar proceso, revisar registro y comprobar resultado, incluyendo retiro de suciedad, cumplimiento de contacto, compatibilidad e integridad. Pruebas microbiológicas o de superficies, si se adoptan, necesitan método y criterio técnico y no se presentan como obligatorias universales.

Áreas, materiales y clasificación de contacto	
Detergente, ficha y compatibilidad	
Desinfectante, ficha y concentración de uso	
Tiempo de contacto y enjuague por producto	
Frecuencias y tiempo reservado en agenda	
Protección, ventilación y almacenamiento	
Método de verificación y criterio	
Capacitación y prueba de tarea	
Hallazgo y corrección	
Adopción local y autenticación	

No conformidad y cierre

Distinguir ausencia de registro de una tarea no realizada; en ambos casos investigar. Repetir antes de liberar cuando la limpieza es incierta y revisar la causa: dotación, capacitación, material incompatible, agenda o supervisión. Cerrar solo con comprobación.

Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

Fecha hora área o elemento	
Tipo de contacto y material	
Tarea prevista	
Producto lote y concentración	
Tiempo de contacto	
Enjuague y secado	
Ejecutor identificado	
Verificación y resultado	
No conformidad	
Acción y liberación	

Fuentes y límites

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Prácticas seguras

Resolución 3100, 11.1.5: política, actividades, instancia proporcional, identificación, comunicación, infección, eventos y consentimiento, documentación y formación; aplicar los criterios pertinentes al servicio.

<https://www.minsalud.gov.co/salud/prestacion-servicios/Paginas/sistema-obligatorio-garantia-calidad.aspx>

Referencia técnica de infección

OMS, Hand hygiene in outpatient and home-based care (2012), estrategia multimodal y cinco momentos. Referencia técnica para adaptación ambulatoria, no reglamento colombiano ni sustituto de etiqueta o fabricante.

<https://www.who.int/publications/i/item/9789241503372>

Régimen temporal de reprocesamiento

Resolución 2183 de 2004 como marco previo y Resolución 914 de 2025, artículos 13-15 y manual DMER. El artículo 15 difiere la vigencia general 18 meses desde publicación (03/07/2025): 03/01/2027; revisar reglas particulares de formación y cambios antes de adoptar.

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No%20914%20de%202025.pdf

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576